

Bipolar I, II und Mischbilder verstehen

Die Begriffe klingen technisch, beschreiben aber eine häufige Verwirrung: Wie stark ist die Hochphase? Wie belastend sind Tiefphasen? Und können Tempo, Unruhe und Verzweiflung gleichzeitig auftreten? Dieses Blatt ersetzt keine fachliche Abklärung, Diagnose oder Behandlung.

WORUM ES GEHT

Angehörige sehen meist Alltag, nicht Diagnosekriterien: wenig Schlaf, mehr Tempo, Rückzug, Gereiztheit, Risiko, Scham oder Verzweiflung. Die Begriffe helfen, Muster vorsichtig einzuordnen.

Bipolar I, Bipolar II und Mischbilder sind keine Rangliste von «leicht» bis «schwer». Entscheidend ist, was zusammenkommt — und wie stark Alltag, Beziehung und Sicherheit kippen.

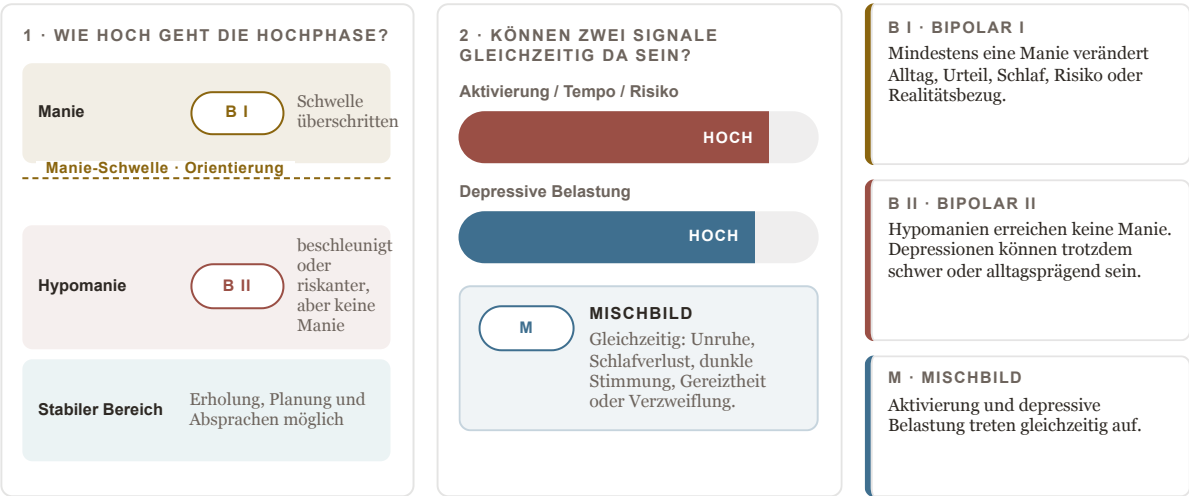
DREI UNTERSCHIEDUNGEN

- **Bipolar I:** Mindestens eine Manie verändert Alltag, Urteil, Schlaf, Risiko oder Realitätsbezug deutlich.
- **Bipolar II:** Hypomanien erreichen keine Manie. Depressive Episoden können trotzdem schwer, lang und alltagsprägend sein.
- **Mischbild:** Aktivierung und depressive Belastung treten gleichzeitig auf.

ENTLASTENDER KERNSATZ

Weniger sichtbar bedeutet nicht weniger ernst. Für Angehörige zählt zuerst: Was verändert sich, was kommt zusammen, wie lange hält es an — und braucht es Unterstützung?

SCHWELLE UND MISCHBILD · DREI DINGE GETRENNT SEHEN



vereinfachtes Modell — keine diagnostische Einordnung

NICHT DIAGNOSTIZIEREN

Die Begriffe sortieren. Ob Kriterien erfüllt sind, gehört in die fachliche Abklärung.

NICHT VERHARMLOSEN

Weniger sichtbare Hochphasen können täuschen, wenn Depression dominiert.

KONKRETER NÄCHSTER SCHRITT

Bei verwirrenden Veränderungen getrennt notieren: Schlaf, Tempo, Stimmung, Risiko und Rückzug.